



Cómo cobra el sistema: pagadores y Art. 30

Dos reglas gobiernan cada renglón de una cuenta. Una la pone el convenio —quién paga y cuánto—. La otra la pone la ley —cuánto hay que rebajarle al adulto mayor—. Se aplican en ese orden y no son intercambiables.

Sistema SIHLA — Sistema Integral Hospital Los Ángeles

Base normativa Decreto Legislativo 199-2006, Art. 30 y 34

Emitido 28 de agosto de 2026

PARTE I · LOS PAGADORES

- 1.1 Todo cargo tiene un pagador
- 1.2 Los cinco tipos, y qué decide cada uno
- 1.3 El seguro externo no es un pagador
- 1.4 El tarifario: un precio por pagador
- 1.5 Cobertura, tope y excedente
- 1.6 Autorización previa y días de crédito
- 1.7 Un convenio no se borra
- 1.8 Cómo sale la factura con seguro

PARTE II · EL DESCUENTO DE LEY

- 2.1 Es una obligación, no una cortesía
- 2.2 Las ocho categorías del Art. 30
- 2.3 La categoría legal no es el tipo de ítem
- 2.4 La edad, a la fecha del servicio
- 2.5 Los porcentajes tienen fecha
- 2.6 Medicamentos: sin receta no procede
- 2.7 La pregunta que la ley no contesta
- 2.8 El descuento del hospital es otra cosa
- 2.9 El techo, y el precio de lista



PARTE I Los pagadores

1.1 Todo cargo tiene un pagador, y el pagador decide el precio

En el sistema, un **convenio** es un pagador. No es un descuento ni una categoría de paciente: es la respuesta a «¿quién paga esta cuenta?». Toda cuenta se abre contra uno, y cada ítem que se le carga se resuelve con el precio que le corresponde a ese pagador el día del servicio.

Por eso **CONTADO existe siempre y no se negocia**: es el pagador del paciente que paga de su bolsillo, y su tarifario es el precio de lista. Sin él, una cuenta sin seguro no tendría a quién cobrarle.

1.2 Los cinco tipos, y qué decide cada uno

El tipo de pagador no es una etiqueta decorativa. Decide una cosa concreta —**si el que paga es el paciente o un tercero**— y de ahí cuelga todo lo demás: si tiene sentido pactarle crédito, si genera cuenta por cobrar, y qué pregunta legal se abre sobre el descuento del adulto mayor.

TIPO	QUIÉN PAGA	QUÉ IMPLICA
Contado	El paciente	Precio de lista. Sin tarifario propio ni días de crédito.
Aseguradora privada	Un tercero	Cobra contra póliza. Trae tarifario negociado, autorización previa y deducible a cargo del paciente.
Seguridad social	Un tercero	IHSS y régimen público. El tarifario y las reglas los fija la institución, no el hospital.
Institucional	Un tercero	Militar, empresa con salud ocupacional, ONG. Responden por las atenciones de su gente.
Seguro externo	El paciente	Sin convenio con el hospital. Paga el paciente y reclama él. Ver 1.3.

1.3 ERROR CARO

El seguro externo se anota, no se le cobra

Es la aseguradora con la que el hospital **no** tiene convenio. El paciente paga todo en caja al precio de lista y después reclama él, con la factura en la mano.

POR QUÉ IMPORTA LA DISTINCIÓN

Si se registra como pagador, el sistema cree que hay algo que cobrarle: queda una **cuenta por cobrar contra una aseguradora que nunca recibió una factura** y que no sabe que existe. Esa plata figura como esperada y nunca entra.

Se registra igual —una sola vez, con nombre y RTN— para que deje de escribirse de veinte formas distintas en un campo libre, y para que salga impresa junto a la póliza, que es lo que el paciente necesita para reclamar.



1.4 El tarifario: un precio por pagador, no un descuento sobre la lista

El precio de un ítem se resuelve por `precio(ítem, pagador, fecha del servicio, sede)`. No es «el precio menos un porcentaje del seguro»: es una fila propia, con su vigencia, en la base de ese pagador.

- **El precio de lista es obligatorio y completo.** Todo lo que el hospital ofrece tiene que tener uno; ahí se ve el catálogo entero y los huecos son lo accionable.
- **La base de un seguro es un acuerdo firmado**, y un acuerdo tiene las líneas que tiene. Ahí solo se ve lo pactado. Lo que no aparece *no es un hueco*: se cobra al precio de lista, que es lo correcto.

Para sumar un ítem está **Agregar ítem**: se elige y se escribe su precio en el mismo acto, que es como se firma un tarifario. Para sacarlo, **Quitar** — si el precio se cargó hoy lo borra; si venía de antes cierra su vigencia ayer y la fila queda, porque con ella se explican las facturas emitidas mientras estuvo viva.

1.5 Cobertura, tope y excedente

Sobre el precio ya resuelto, tres campos del convenio deciden cómo se parte cada renglón entre el seguro y el paciente:

- **Cobertura** — la fracción que paga el seguro. `0.80` es el 80 %, el reparto típico del mercado hondureño. `0` significa que el paciente paga todo.
- **Tope por evento** — el techo de esa cobertura en este evento. Vacío es sin tope. **Lo que pase del tope lo paga el paciente.**
- **Cubre lo que no tiene precio propio** — encendido, el seguro también responde por ítems fuera de su tarifario. Apagado, solo cubre lo declarado.

CONGELADO EN EL CARGO

Cada cargo guarda su cobertura al momento de nacer. Si mañana se renegocia el convenio, las cuentas de ayer siguen repartidas como se pactó ayer — que es lo que permite explicar una factura vieja sin adivinar.

1.6 Autorización previa y días de crédito

Exige autorización previa. Sin autorización, el hospital atiende y después descubre que el pagador no cubría: la factura queda en el aire y el que reclama es el paciente. La marca está para que eso se pida antes, no después.

Días de crédito. Vacío significa que se cobra al momento. Solo tiene sentido cuando paga un tercero —al contado no se fía a treinta días— y la base lo impide con una verificación propia. De este campo sale el vencimiento que se imprime en la factura, y desde ahí se cuenta la mora.

1.7 Un convenio no se borra: se cierra con fecha

Terminar un convenio es ponerle **fecha de fin de vigencia**, nunca eliminarlo. Sus cuentas, sus cargos y sus facturas tienen que seguir explicándose, y un pagador borrado deja años de documentos apuntando a la nada.



1.8 Cómo sale la factura cuando hay seguro

Es lo que el hospital ya venía haciendo en papel, y el sistema lo reproduce:

- **El renglón del cliente lleva los dos nombres:** «PAN-AMERICAN LIFE / MARÍA JOSÉ GÓMEZ». El seguro porque es quien paga; el paciente porque sin él la aseguradora no sabe a qué asegurado corresponde.
- **El documento es el RTN de la aseguradora**, no la identidad del paciente. Una factura a nombre del paciente no le sirve al seguro para reembolsar.
- **El código de cliente es el número de póliza**, que es por donde la aseguradora busca al asegurado cuando reembolsa.

PENDIENTE DE CARGA

Mientras la aseguradora no tenga **RTN cargado**, el sistema propone el documento del paciente para no emitir «sin documento» arriba del umbral. Es lo menos malo, no lo correcto.



PARTE II El descuento de ley

2.1

OBLIGACIÓN LEGAL

Es una obligación, no una cortesía del hospital

El descuento del adulto mayor lo ordena el **Artículo 30 del Decreto Legislativo 199-2006**, Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados. No se «autoriza» caso por caso ni se negocia en ventanilla: si el paciente califica y el ítem cae en un numeral del artículo, corresponde.

De ahí sale la única pregunta que importa cuando llega una denuncia a la línea 115: «¿por qué a este ítem le aplicaron 30 %?». La respuesta tiene que ser un numeral, y por eso cada ítem del catálogo lleva escrito el suyo.

2.2

Las ocho categorías del Art. 30

Cada ítem del catálogo se clasifica en una de estas. Los porcentajes son los **de referencia** —los que se sembraron—; el motor factura contra la tabla con vigencia, no contra esta lista (ver 2.5).

CATEGORÍA	NUMERAL	TERCERA	CUARTA
Servicio hospitalario	Art. 30 · num. 5	25 %	40 %
Medicamento o material quirúrgico	Art. 30 · num. 6	25 %	40 %
Consulta médica general	Art. 30 · num. 7	25 %	40 %
Consulta médica especializada	Art. 30 · num. 7	30 %	40 %
Intervención quirúrgica	Art. 30 · num. 8	30 %	40 %
Odontología, optometría y oftalmología	Art. 30 · num. 8	30 %	40 %
Radiología y laboratorio	Art. 30 · num. 8 y 9	30 %	40 %
Medicina computarizada	Art. 30 · num. 9	30 %	40 %
Sin descuento legal	—	0 %	0 %

«Sin descuento legal» no es «todavía no lo clasifiqué». Es una afirmación: este ítem —cafetería, parqueo, alquiler a terceros, estética— no está en el Art. 30 y no lleva descuento. Por eso hay que elegirla a propósito y no es el valor por defecto de nada.



2.3 La categoría legal no es el tipo de ítem

Son dos ejes distintos y confundirlos es el error de clasificación más común.

- Consulta general y consulta especializada son **las dos honorarios** —el mismo tipo de ítem— y llevan porcentajes distintos.
- Una radiografía es un estudio de imagen y una extracción dental es un procedimiento —**tipos distintos**— y llevan el mismo porcentaje, porque la ley los metió en el mismo numeral.

El eje del descuento es el **texto de la ley**, no la taxonomía interna del catálogo. Al crear un ítem el sistema *sugiere* una categoría según el tipo, pero es una sugerencia: el honorario de un cardiólogo es especializada aunque el tipo diga «honorario».

2.4 La edad se mide a la fecha del servicio

No contra hoy, y no contra la fecha de facturación. **El paciente que cumplió sesenta el mes pasado no tenía derecho en la cirugía de marzo**, y el que los cumplió en marzo lo tiene aunque se facture en agosto.

RANGO	EDAD CUMPLIDA	LLEVA DESCUENTO DE LEY
Normal	0 – 59 años	No
Tercera edad	60 – 79 años	Sí
Cuarta edad	80 años en adelante	Sí, con porcentaje propio

Los cortes son **configuración, no código**: la ley ya cambió una vez y va a volver a cambiar. Mover 60 u 80 es editar una línea, no un despliegue.

2.5 Los porcentajes tienen fecha, y por eso viven en una tabla

La pantalla **Descuentos de ley** no es un catálogo de constantes: cada fila tiene vigencia y cita el decreto que la sustenta. Una factura de hace dos años tiene que poder reimprimirse con el porcentaje que regía *el día del servicio*, y una constante en el código no tiene fecha.

Por eso, cuando la ley cambie, la operación es **agregar una fila nueva con su vigencia** y cerrar la anterior —nunca editar el número viejo. Editarlo reescribiría el pasado.

2.6 ART. 34

Medicamentos: sin receta, el descuento no procede

El Art. 34 exige **receta original firmada y sellada** para el descuento sobre medicamentos. En dispensación a paciente internado sale de la orden médica y es automático. **En venta de mostrador hay que capturarla**, y si no la hay el descuento no corresponde.

Ojo con la distinción: un medicamento controlado también exige receta, pero eso es requisito para *dispensar*. Acá el requisito es para *descontar*. Son dos cosas distintas que se cumplen con el mismo papel.



2.7

REQUIERE CRITERIO LEGAL

La pregunta que la ley no contesta

El Art. 30 está escrito pensando en el paciente que paga en caja. **No dice qué pasa cuando el que paga es un seguro.** Hay tres lecturas defendibles y dan facturas distintas, así que el sistema no elige por su cuenta: cada convenio la declara a mano, junto al fundamento escrito de por qué.

OPCIÓN	QUÉ SIGNIFICA
Sobre lo que paga el paciente	El descuento cae solo sobre el deducible, coaseguro o copago que el paciente desembolsa. Lo que cubre el pagador queda fuera de la base.
Sobre el total facturado	El descuento cae sobre el total, lo pague quien lo pague. Es la lectura más literal del artículo y la más favorable al paciente; también la que más discute el pagador.
No aplica en este convenio	El esquema ya contempla el beneficio, o la cobertura es total y no queda monto del paciente sobre el cual calcular.

LO QUE EL SISTEMA GARANTIZA Y LO QUE NO

Garantiza que la decisión quede **escrita, fechada y atribuida a alguien**, en vez de aplicarse en silencio por un valor por defecto que nadie eligió. **No es asesoría legal.** Elegir la opción correcta requiere criterio profesional sobre el texto consolidado.

2.8

POLÍTICA DE DIRECCIÓN

El descuento del hospital es otra cosa

El que se teclea en la ventana de la cuenta —«hacele un 10 %»— **no es ley: es política de dirección.** Por eso vive en configuración y no en la tabla de descuentos legales, y por eso tiene topes distintos según a quién se le da:

A QUIÉN	PUEDE DARLE EL HOSPITAL	POR QUÉ
Sin descuento de ley	hasta 30 %	El margen entero está disponible.
Tercera edad	hasta 10 %	Sobre el 25 % de ley. Total 35 %.
Cuarta edad	0 %	Ya recibe el porcentaje más alto, que es el techo.

El cero de la cuarta edad no es tacañería: **el precio de lista se calculó dividiendo por ese mismo porcentaje máximo.** Un punto más no sale del precio, sale del margen. Y el orden importa —el paciente de 80 tiene que terminar pagando menos que el de 65—: eso es lo que mantiene el esquema del lado legal.



2.9 El techo, y por qué el precio de lista parece alto

Las dos rebajas se suman y chocan contra un techo: **descuento de ley + descuento del hospital nunca puede pasar el máximo legal de la categoría**. El sistema no avisa: rechaza el cargo. Subir los topes de dirección no alcanza para saltarlo.

Y de ahí sale el precio de lista de todo el catálogo. No es un número puesto a ojo: se deriva del costo y del *peor* descuento posible del ítem, para que el margen mínimo se cumpla incluso con el paciente que menos paga.

$$\text{lista} = \text{costo} \times (1 + \text{margen}) \div (1 - \text{descuento máximo})$$

↑ el del rango de edad que más descuento recibe

UN RENGLÓN, DE PUNTA A PUNTA

Consulta especializada, precio de lista	L 1,080.00
Paciente de 68 años · tercera edad · num. 7 → 30 %	- L 324.00
El hospital agrega un 10 % (su tope para tercera edad)	- L 108.00
Cobertura del seguro 80 % sobre lo que queda	L 518.40
Le toca al paciente	L 129.60

Las cifras son un ejemplo para leer el orden de las operaciones. El reparto real depende de la base declarada en el convenio (2.7) y del tope por evento (1.5).



Lo que todavía no está resuelto

Tres cosas de este instructivo dependen de decisiones que no son técnicas. Se listan acá para que queden a la vista de quien tenga que tomarlas.

1 · LA BASE DEL DESCUENTO CUANDO PAGA UN SEGURO

Cada convenio ya declara su opción y su fundamento, pero **ninguna está validada profesionalmente**. Es el pendiente más viejo del módulo y el que más plata mueve.

2 · LOS PORCENTAJES DE LA CUARTA EDAD

La tabla sembrada tiene **40 % para la cuarta edad** citando el Decreto Legislativo 59-2023. Existe también la lectura contraria —que en salud el techo es 30 % desde los 60 años y que la cuarta edad corresponde al Art. 31, no al 30—. **Los dos versiones no pueden ser ciertas**. Conviene confirmarlo contra el texto de La Gaceta antes de la primera factura a un paciente de 80 años.

3 · DATOS PENDIENTES DE CARGA

El convenio PALIG tiene el tarifario cargado pero el **porcentaje de cobertura y el RTN en cero**. Mientras sigan así, el sistema le carga todo al paciente y la factura sale con el documento del paciente en vez del RTN de la aseguradora.

SIHLA – Sistema Integral Hospital Los Ángeles · Santa Rosa de Copán, Honduras
Documento interno de referencia. No constituye asesoría legal ni fiscal.
Base normativa citada: Decreto Legislativo 199-2006, Artículos 30 y 34.